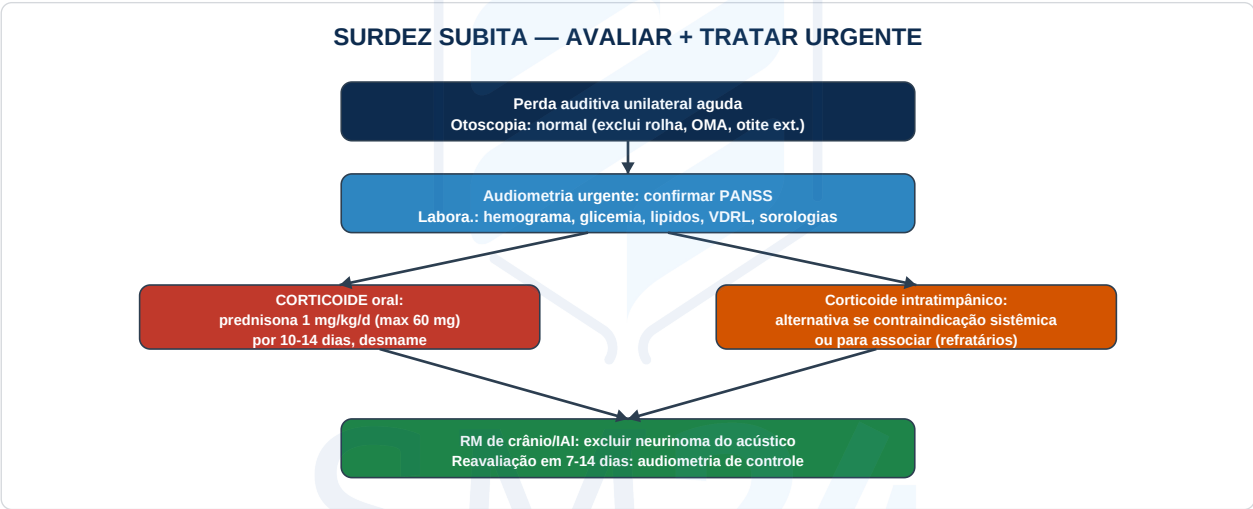


SURDEZ SUBITA — EMERGÊNCIA — CORTICOIDE EM 72H

DEFINIÇÃO E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Critério	Definição
Definição	Perda auditiva neurossensorial ≥ 30 dB em 3 frequências consecutivas em ≤ 72 h
Prevalência	5-20/100.000 hab/ano; pico 50-60 anos; geralmente unilateral
Apresentação	Acorda sem ouvir ou perde audição subitamente; pode ter zumbido, plenitude auricular, vertigem
Diagnóstico	Audiometria tonal liminar: curva descendente ou plana, neurossensorial
Urgência	Emergência otológica — iniciar corticoide em <72 h (melhor chance de recuperação)
Prognóstico	Recuperação espontânea 45-65%; com tratamento: melhora em 70-80%; frequências agudas pior prognóstico

ABORDAGEM NA EMERGÊNCIA



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diagnóstico	Como diferenciar
Rolha de cerúmen/corpo estranho	Otosopia: rolha visível; audiometria: condutiva
Otite média aguda / efusão	Timpanograma tipo B; otosopia: hiperemia ou derrame
Neurinoma do acústico (schwannoma)	RM de IAI: massa em canal auditivo interno; geralmente lenta mas pode ser subita
AVC de tronco (cerebelar)	Vertigem + nistagmo + outros sinais tronco (diplopia, disfagia, ataxia)
Síndrome de Ménière	Tríade: vertigem + hipoacusia + zumbido em episódios; audiometria: graves afetados primeiro
Doença de Lyme / sífilis (neuroSSN)	Sorologias; exposição; tratamento específico com penicilina ou doxiciclina

FATORES DE PROGNÓSTICO

PIOR PROGNÓSTICO

- Idade avançada (>60 anos) e DM, HAS, dislipidemia
- Perda auditiva grave (>60 dB) ou profunda
- Frequências agudas afetadas (configuração descendente)
- Tratamento tardio (>7 dias da instalação)
- Vertigem associada (acometimento vestibular simultâneo)
- Ausência de resposta após 1a semana de corticoide

CORTICOIDE — VIA ORAL vs INTRATIMPÂNICA

Corticoide Oral (1a linha)

- Prednisona 1 mg/kg/d (max 60 mg) por 10-14 dias
- Desmame gradual nos últimos 4-5 dias
- Iniciar em <72h do início dos sintomas
- Contraindicações: DM não controlado, infecção ativa, glaucoma
- Metilprednisolona IV: hospitalizados ou forma grave (perda >60 dB)

Corticoide Intratimpânico

- Dexametasona 4-24 mg/mL: injeção transtimpânica
- Indicação: contraindicação ao sistêmico OU falha parcial após oral
- Vantagem: concentração coclear alta sem efeito sistêmico
- Pode ser associado ao oral (melhor desfecho em estudos recentes)
- Procedimento ambulatorial: anestesia local, 0,4 mL intratimpânico

NAO PERDER TEMPO — CHECKLIST NO PS

AGIR EM 72H

- ☐ Otoscopia: excluir causa condutiva tratável (rolha, OMA) — não iniciar corticoide sem audiometria
- ☐ Audiometria: confirmar PANSS e quantificar perda — urgente no mesmo dia
- ☐ Solicitar RM de crânio/IAI: para excluir neurinoma — pode ser eletivo mas não atrasar o corticoide
- ☐ Laboratorial: VDRL (sífilis!), hemograma, glicemia, TSH, sorologias virais
- ☐ Corticoide oral: iniciar no PS se audiometria confirmada + diagnóstico diferencial descartado
- ☐ Retorno em 7 dias: audiometria de controle — se refratário: acrescentar intratimpânico

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Mulher de 52 anos acorda sem ouvir do ouvido direito + zumbido. Otoscopia normal. Qual é o diagnóstico e conduta?

- A) Rolha de cerúmen — irrigação e alta
- B) Surdez súbita neurosensorial — audiometria urgente + prednisona 1 mg/kg/d em <72h
- C) Otite média aguda — amoxicilina 500 mg 8/8h
- D) Síndrome de Ménière — betahistina e diurético
- E) Neurinoma do acústico — RM e encaminhar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal objetivo do tratamento com corticoide na surdez súbita?

- A) Tratar infecção viral coclear
- B) Reduzir o edema do nervo auditivo e estria vascular — melhorar microcirculação coclear
- C) Prevenir neurinoma do acústico
- D) Anular o zumbido associado
- E) Evitar propagação para o ouvido contralateral

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual exame é imprescindível para confirmar o diagnóstico de surdez súbita neurosensorial?

- A) TC de mastoides
- B) RM de crânio
- C) Audiometria tonal liminar — confirma perda neurosensorial ≥ 30 dB em 3 frequências
- D) Potencial evocado auditivo (BERA)
- E) Timpanograma

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Em qual situação a surdez súbita tem PIOR prognóstico de recuperação?

- A) Início aos 30 anos sem comorbidades
- B) Perda auditiva leve com frequências médias afetadas
- C) Perda auditiva profunda com vertigem associada e tratamento iniciado após 7 dias
- D) Tratamento iniciado em <24h com prednisona oral
- E) Perda isolada em frequências graves (250-500 Hz)

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que a RM de crânio/canal auditivo interno é solicitada na surdez súbita?

- A) Para confirmar o diagnóstico de surdez súbita
- B) Para guiar a aplicação de corticoide intratimpânico
- C) Para excluir neurinoma do acústico (schwannoma vestibular), que pode se apresentar como surdez súbita em 1-2% dos casos
- D) Para medir o volume da cóclea e ajustar a dose de corticoide
- E) Para avaliar integridade do osso temporal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Surdez súbita: otoscopia normal (exclui condutiva) + início agudo unilateral = PANSS até prova em contrário. Audiometria urgente para confirmar. Corticoide oral (prednisona 1 mg/kg) dentro de 72h — janela terapêutica. Além de 72h: menor chance de recuperação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Mecanismo proposto da PANSS: isquemia coclear (espasmo da artéria auditiva interna, trombose), inflamação viral do nervo coclear, ruptura de membrana. Corticoide: reduz edema, melhora microcirculação coclear, efeito anti-inflamatório/imunossupressor. Melhora em 70-80% com tratamento precoce.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Audiometria tonal liminar: confirma PANSS (≥ 30 dB em 3 frequências consecutivas) e diferencia de condutiva (curvas separadas para via aérea e óssea). Sem audiometria não se confirma o diagnóstico. RM: complementar, para excluir neurinoma. TC: avalia osso temporal.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Pior prognóstico: perda profunda ($>60-90$ dB) + vertigem associada (acometimento vestibular concomitante) + tratamento tardio (>7 dias). Também: frequências agudas, idoso, DM. Melhor: início <24 h, frequências graves, sem vertigem, tratamento em <72 h.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Neurinoma do acústico (schwannoma vestibular): tumor benigno do nervo vestibulococlear. Em 1-2% pode se apresentar como surdez súbita. RM com contraste (gadolínio) é o padrão-ouro. Não retardar o corticoide esperando RM — solicitar eletivamente enquanto trata.

SM24
Suporte ao Plantão Médico